

Sotsiaalne innovatsioon – kellele ja kuidas?



Gerli Aavik

hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

Euroopa rahvastik vananeb ja senine heaolu-riigi mudel seisab väriseval jalgal. Töökas inimesi jääb vähemaks, surve eelarvele tugevneb, ent ootused teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele kasvavad. Inimesed ootavad üha enam, et teenused oleksid proaktiivsed ja intuiitiivsed, nagu on erasektoris pakutav. Üha enam soovivad inimesed ka ise teenuste kujundamisel osaleda.

Nii vastandlike ootustega toimetulekuks vajame uusi lähenemisi. Tihti arvatakse, et innovatsioon tähendab vaid tehnoloogia arengut ja IT-lahendusi. Ent innovatsioon võib peituda ka palju lihtsamates asjades, näiteks inimestele suurema otsustusvõimaluse andmises, lahenduste laenamises teistest sektoritest jne.

Ka rahvusvahelises teaduskirjanduses räägitakse üha enam koosloomest, kogukondade võimestamisest, teenusedisainist jt mittetehnoloogilistest innovatsiooni tööriistadest. IKT saab innovatsiooni arengut muidugi oluliselt võimestada: näiteks hästi arendatud IT-lahendused tagavad jagamisplatvormide kasutajamugavuse ja avaandmete oskuslik kasutamine toetab teadmispõhiste otsuste langetamist. Tehnoloogia aitab lahendada olukordi, kus vajaliku oskusteabega inimesi napib. Kuid ka tehnoloogiakauged inimesed ei pea innovatsiooniteemalistest diskussioonidest kõrvale jääma.

Abivajaja või teenusedisainer?

Praeguses hoolekandepoliitikas pingutatakse selles suunas, et abivajadusega inimene oleks hoolekande subjekt, mitte objekt. Ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni üheks aluspõhimõtteks on, et puudega inimesi puudutavaid otsuseid tuleb langetada koos nende endiga. See põhimõte ei ole oluline vaid inimõiguste tagamise ja kaasamise hea tava seisukohast. Ainult abivajadusega inimesed ise saavad teenuselukujundamise keskmesse tuua **tervikliku kliendikogemuse ja -teekonna**, pakkudes nii olulist lisaväärtust teadmispõhisele poliitikakujundamisele. Kui varem on kaasamine tähendanud pigem juba valmis plaani kooskõlastamist eri sihtgruppidega, siis inimkeskne teenusedisaini jt uuemad meetodid näevad ette, et abivajadusega inimene peab poliitikakujundamise keskmes olema juba selle esimestes etappides.

Ka Eestis on juba head näited olemas. Näiteks on inimkeskse teenusedisaini meetodeid kasutatud nii rehabilitatsiooni- kui erihoolekandeteenuste ümberkujundamisel. Rehabilitatsiooniteenuste puhul kaardistati kõigepealt olukord ja probleemid. Selleks loodi sihtgruppi esindavad näidispersoonad (nt Mari, 34aastane, elab Põlvamaal, kahe lapse ema). Seejärel intervjueriti selliseid persoonasid

esindavaid abivajadusega inimesi, nende lähedasi, sihtgrupiga tegelevaid teenuseosutajaid ja eksperte. Intervjuude põhjal joonistati välja klienditeekonnad (vt foto 1), mille ümber ehitati fookusgrupi töötoad.

Neisse töötubadesse toodi kokku eri osapooled: sihtgrupi esindajad, lähedased, teenuseosutajad, eksperdid, kohaliku omavalitsuse esindajad, teenuste rahastajad ja poliitika kujundajad. Töötubades keskenduti varem kirjeldatud klienditeekondadele ning otsiti lahendusi valupunktile. Mitmeid teenuseid (nt taastusravi, rehabilitatsioon ja abivahendid) vaadeldi ühiselt inimese vaatepunktist. Erihoolekande teenusedisaini protsessis keskenduti kohe inimeste vajadustele, jättes kõrvale kehtiva teenusekorralduse.

Mõlemad protsessid on jõudnud katsefaasi. Rehabilitatsiooniteenuste puhul testitakse integreeritud mudeleid, et inimese liikumine teenusesüsteemide vahel oleks sujuv. Erihoolekandeteenuste puhul pannakse teenus sobivatest komponentidest kokku iga inimese vajadustest lähtudes. Mõlemad juhul lähtutakse **inimesest ja tema individuaalsetest vajadustest**, kirjeldatud põhimõtteid saab kasutada eri teenussüsteemide ja sihtgruppide juures.

Võib juhtuda ka nii, et ühe inimese abivajadus aitab lahendada teise oma. Näiteks Hollandis on testimisel mudel, kus seoti eakate üksilduse ja tudengite elukoha probleem. Tudengitele pakutakse tasuta elamispinda eakate hooldekodus ja tudengid omakorda veedavad aega asutuses elavate eakatega. Lahendus on küll väga lihtne, ent siiski innovaatiline, sest sellisest kooselust võidavad mõlemad osapooled: üksteisele pakutakse seltsi, vahetatakse elukogemusi ja värskendatakse vaateid. Samal ajal lahendatakse aga kaks olulist sotsiaalset probleemi: eakate üksildus ja tudengite liiga kallis elamispind. Sama mudelit saab lihtsalt rakendada mujalgi.



Foto 1. Intervjuude põhjal loodud ja fookusgrupi töötubades täiendatud klienditeekonnad

Sarnaseid näiteid leiab ka USAst, kus on näiteks ühendatud lasteaedade ja eakate hooldekodude funktsioonid, et tuua mõlema osapoole igapäevaellu vaheldust ja rõõmu.

Alahinnata ei tasu ka tehnoloogiat

Tehnoloogia areneb pidevalt ja koos sellega tekivad uued võimalused avalike teenuste pakkumiseks. Näiteks digitaalne allkirjastamine on muutunud paljude avalike teenuste kasutamise mugavamaks ja kiiremaks. Kiire tuludeklaratsiooni esitamise võimalus on Eestile toonud ka rahvusvahelist kuulsust.

Lihtsamaks on muutunud ka sotsiaalteenuste taotlemine, ent arenguruumi on siin veel kõvasti. Tehnoloogiline innovatsioon ei tähenda aga vaid riiklike e-lahenduste arendamist. Digitaalsed lahendused aitavad distantsilt koguda ja jälgida terviseandmeid,

teha mänguliselt füsioteraapiaharjutusi ja suhelda videosilla abil spetsialistidega. Sellised lahendused võivad aidata abivajadusega inimestel iseseisvalt hakkama saada, hoida kontakti pereliikmetega ja enda heaolu parandamiseks teadlikumalt otsuseid langetada.

Põnev näide on Eestis arendatud suhtluskeskkond Sentab (www.sentab.com/ee). See laseb eakatel oma pereliikmetega kontakti hoida, arendavaid mängu mängida ja suhtlusvõrgustikke laiendada. Kõrgtehnoloogilised abivahendid aitavad liikumiskeskustes inimestel paremini liikuda, vaegnägijad ja -kuuljad koguvad nende abil vajalikku infot ning psüühilise erivajadusega inimesed maandavad tekkivat ärevust. Tehnoloogia arengust ja võimalustest peaksid osa saama **kõik sihtgrupid**.

Erasektoris on juba üsna igapäevased ka jagamismajanduse põhimõttel toimivad lahendused nagu Airbnb majutuskoha leidmiseks, Uber ja Wisemile sõitude jagamiseks ning mitmed müügiplatvormid tarbeesemete müümiseks ja vahetamiseks.

Töenäoliselt muutuvad peagi sarnased lahendused ka hoolekandes igapäevatöö osaks. Jagamismajanduse põhimõttel on eestlased juba üles ehitanud platvormi Helpific (<https://helpific.com/et>). See Euroopas üsna ainulaadne platvorm toob kokku abivajajad ja need, kes on valmis teisi abistama. Helpific on hea näide, kuidas vana lahenduse kasutamine uues keskkonnas (ehk siis jagamismajanduse platvormi kasutamine hoolekandesektoris) toob kaasa täiesti uued võimalused ja kasutajamugavused. Sarnase loogika alusel tegutses Pariisis algatus Wheeliz, mis viib kokku kohandatud transpordi omanikud ja selle vajajad. Erivajadusega inimene, kes nädalavahetusel kohandatud sõidukit ise ei vaja, saab selle anda mugavalt ja turvaliselt kellegi teise kasutusse ja teenida seejuures lisaraha.

Võib loota ja eeldada, et taolised lahendused leiavad koha meie turul. Loomulikult on uutel lahendustel ka oma riskid ja puudused. Kuid puuduste võimendamise asemel tasub ühiselt otsida võimalusi riskide maandamiseks. Taolised lahendused võivad olla päästerõngaks olukordades, kus abivajajad on järjest rohkem valmis aktiivselt igapäevaelus osalema, ent neile vajaliku toe pakkumiseks napib väljaõppinud spetsialiste.

Andmed loovad võimalusi

Kuulsas 1980. aastate hittsarjas „Jah, minister” soovib äsja ametisse saanud minister kehtestada avatud valitsemise põhimõtte, mispeale ministeeriumi kantsler Sir Humphrey ütleb: „See on mõistete vastuolu. Sa võid olla avatud või sul võib olla valitsus.”

Õnneks oleme palju edasi liikunud ning vähemalt Euroopa Liidu riikides lähtutakse suuresti avatud valitsemise põhimõtetest. Avatud valitsemise lähtepunkt on see, et otsuste tagamaad ja dokumendid on avalikud ning kodanikud saavad poliitika kujundamises kaasa rääkida. Innovatsiooni toetamiseks on aga võimalik minna veel samm edasi ning muuta riigil olemasolevad andmed teiste osapoolte jaoks lihtsasti kasutatavaks, andes nii ka vajalikku infot uute teenuste arendamiseks ja lahenduste pakkumiseks. Kui suurte andmemahutude kasutamine on enamasti ajamahukas ja nõuab erioskusi, siis visualiseeritud ja eeltöödeldud andmete jagamine annab asjast huvitatutele olukorrast kiire ülevaate.

Hea näide on Eesti Haigekassa raviarvete andmekogu baasil tehtud visualiseeritud ülevaade eriarstiabi saanute arvust ja kuludest vanuse ning põhidiagnoosi järgi¹. Selline ülevaade võimaldab andmetesse süveneda nii teemast huvitatud kodanikul kui ka võimalikul arendajal või investoril, kes soovib valdkonnas midagi uut ära teha. Andmete

eelanalüüs võib asutuste jaoks olla küll ajamahukas ja kallis, ent nende ring, kellel on tulemustest kasu, on suur ja see tagab asutuse usaldusväärsuse kasvu.

Teaduskirjanduses kohtab järjest rohkem mõistet valitsus kui platvorm. See tähendab seda, et valitsus peab looma eeltingimused, mis võimaldavad kõigil seotud osapooltel (eraettevõtted, vabaühendused, akadeemia jne) panustada riigi ja teenuste arendamisse.

Maailmas on huvitavaid näiteid, kus andmete avamine on võimaldanud arendada uut moodi avalikke teenuseid ning nii arendamise kui ka pakkumise faasis toimub teenuse **sisuline koosloome riigiasutuse, erasektori ja kodanike vahel**.

Üheks parimaks näiteks pean Chicago linnavalitsuses tehtut, kus hea kvaliteediga avaandmed on muutnud avalike teenuste arendamise ettevõtjate ja teadlaste jaoks atraktiivseks. Koostöö käib nii, et ettevõtted ja teadusasutused arendavad avaandmetele toetudes uusi teenuseid ja Chicago linn saab neid tasuta kasutada. Arendajad saavad linnavalitsuselt olulist sisendit teenuse arendamiseks ja hiljem tagasisidet teenuse kasutatavusest, linn aga saab tasuta kompetentsid ja uued lahendused. Digitaalsete lahenduste koodid on avalikud ja nii on protsessi kaasatud ka aktiivsed kodanikud. Koostöös arendatakse lahendusi niikaua, kuni need on n-ö küpsed. Siis saab ettevõtja aga valmis lahenduse müüa teistele piirkondadele või riikidele. Chicago linnal on aga õigus teenust tasuta edasi kasutada. Chicago on sellisel viisil saanud endale mitmeid ennustava analüütika lahendusi, näiteks on kasutusel ja arendamisel algoritmid, millega varakult tuvastada toiduohutuse rikkumisi, teha teadmispõhiseid rinnavähiskriininguid ja vähendada väikelaste suremust. Mitme osapoole koostöös arendatud lahenduste

eelduseks on korralikud avaandmed. Ehk võiks Eesti uus Skype olla avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös arendatud ja kasutusele võetud hoolekandeteenused, mida eksportida teistesse riikidesse?

Kuidas saab riik innovatsiooni toetada?

Inimeste ootused avalikele teenustele on nüüd kõrgemad, kui need olid mõnekümne aasta eest. Selleks et tulla toime olukorras, kus abivajadusega inimeste hulk kasvab, ent tööealiste elanike arv kahaneb, on vaja uusi lähenemisi ka sotsiaalvaldkonnas. Vajame innovatsiooni igal tasandil – keskvalitsuses ja kohalikes omavalitsustes, erasektoris, ülikoolides, vabaühendustes ja ka iga inimese panusena.

Selleks on mitmeid võimalusi: osapoolte teadlik kaasamine ja võimestamine, riigisektori kogutud andmete avalikustamine, nii et neile toetudes saaks arendada uusi lahendusi jne. Uue lähenemisena on korraldatud ka ideekonkurss, nn häkatone, kus sarnaselt Ajujahi konkursile on võimalik huvitavaid ideid mentorite toel prototüüpideks arendada, parimad saavad vajalikku toetust, et välja arendada prototüüp tooteks või teenuseks. Nii on loodud ka varem mainitud Helpific ning kindlasti on mitmed head lahendused alles arengufaasis.

Selleks et soodustada innovatsiooni ja toetada uute lahenduste kasutuselevõttu, on sotsiaalministeeriumis väljatöötamisel **innovaatiliste lahenduste arendamiseks suunatud toetusmeede**. Toetusmeetme eesmärk on suurendada sotsiaalvaldkonna teenuste või toodete kättesaadavust innovaatiliste lahenduste abil. Raha taotlema ootame nii omavalitsusi, ettevõtteid kui kodanikuühendusi, kes soovivad arendada tooteid või teenuseid, mis on suunatud hool-

¹ Ülevaade kättesaadav siin: www.stacc.ee/ehif-stacked-area/?lng=Et.